

Maladie de La Peyronie

WARWIKI

Information pour le patient · Un tissu cicatriciel qui courbe le pénis — et ce qui peut aider

La maladie de La Peyronie est une affection dans laquelle une zone de tissu cicatriciel (une **plaque**) se forme dans la paroi du pénis, provoquant une **courbure**, un **rétrécissement**, une **indentation** ou un **raccourcissement**, parfois accompagnés de douleurs lors des érections. Elle peut rendre les rapports sexuels difficiles. Elle est fréquente, elle **n'est pas un cancer**, et des traitements efficaces existent — le choix dépend du stade.

À propos de cette affection

La maladie de La Peyronie évolue généralement en deux phases :

- **Phase active (aiguë)** — la courbure est encore en train de changer et il peut y avoir de la douleur, souvent pendant 6 à 18 mois.
- **Phase stable** — la courbure et la plaque se sont stabilisées et la douleur a généralement diminué.

Le choix du traitement dépend de la phase dans laquelle vous vous trouvez ; votre équipe soignante vous demandera donc comment les choses ont évolué au fil du temps.

Causes

On pense que la maladie fait suite à un léger traumatisme ou à une torsion pendant un rapport sexuel, qui cicatrise de façon anormale au lieu de guérir normalement. Elle est plus fréquente avec l'âge, en cas de diabète, après une chirurgie de la prostate et chez les hommes qui ont également une **maladie de Dupuytren** (une affection similaire touchant la main).

COMPRENDRE LES TERMES

Maladie de La Peyronie

Tissu cicatriciel dans le pénis provoquant une courbure ou une déformation.

Plaque

La zone de tissu cicatriciel responsable de la courbure.

Active vs. stable

Indique si la courbure est encore en train d'évoluer ou si elle s'est stabilisée.

Thérapie par traction

Un dispositif qui étire doucement le pénis pour améliorer la courbure et la longueur.

Collagénase (Xiaflex)

Un médicament injectable qui dégrade la plaque.

Plication / greffe

Techniques chirurgicales pour redresser le pénis.

DOIS-JE ME PRÉCIPITER VERS LA CHIRURGIE ? Généralement non. En **phase active**, la courbure est encore en train d'évoluer ; l'objectif est donc le confort et les options non chirurgicales. La chirurgie de redressement est proposée une fois la situation **stable** (après que la courbure s'est maintenue et que la douleur s'est calmée). Beaucoup d'hommes s'améliorent sans opération.

Comment on le diagnostique

- Un historique de la courbure, de la douleur et de son évolution
- Un examen pour palper la plaque ; parfois des photos d'une érection ou une évaluation en cabinet
- Parfois une échographie pour cartographier la plaque et le flux sanguin

Comment on le traite (selon la phase)

- 1 Phase active** — réassurance, contrôle de la douleur et souvent **thérapie par traction** ; l'objectif est de limiter l'aggravation.
- 2 Injections dans la plaque** — des médicaments comme la **collagénase (Xiaflex)** sont injectés dans la plaque pour réduire la courbure.
- 3 Chirurgie (phase stable)** — **plication** (suture du côté le plus long ; technique la plus simple, peut raccourcir le pénis) ou **incision/greffe de la plaque** (préserve la longueur, pour les courbures sévères).
- 4 Prothèse pénienne** — en cas de dysfonction érectile associée. Chaque option fait l'objet d'une fiche séparée.

Bon à savoir

- N'essayez pas de redresser le pénis de force — cela peut aggraver la blessure.
- Une courbure qui n'empêche pas les rapports peut simplement être surveillée.
- La maladie de La Peyronie peut affecter l'humeur et les relations — le soutien est important.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Une courbure qui **empêche les rapports sexuels** ou qui s'aggrave
- Une **douleur** importante lors des érections
- Une nouvelle **dysfonction érectile** accompagnant la courbure

TROIS CHOSES À RETENIR

- 1.** La maladie de La Peyronie est un tissu cicatriciel qui courbe le pénis — fréquente, pas un cancer, et traitable.
- 2.** Le traitement dépend de la phase : confort et options non chirurgicales en phase active ; procédures de redressement une fois stable.
- 3.** Beaucoup d'hommes s'améliorent sans chirurgie. Consultez votre équipe en cas de courbure gênante, de douleur persistante ou de nouvelle dysfonction érectile.